

1

消化器症状

悪心・嘔吐・下痢・口内炎への対応

1 起こりやすい薬剤・催吐リスク分類

高度催吐性 (High)

シスプラチン等。90%超で悪心嘔吐が発現。予防的に3剤併用(NK1受容体拮抗薬+5-HT3拮抗薬+デキサメタゾン)が推奨される

中等度催吐性 (Moderate)

オキサリプラチン・イリノテカン等。30～90%で発現。5-HT3拮抗薬+デキサメタゾンの2剤併用が基本

軽度・最小度 (Low/Minimal)

フルオロウラシル・分子標的薬の多くなど。予防投与は必要最小限、または不要なことも

2 発現時期の目安



急性

投与後24時間以内



遅発性

投与2～5日後



予期性

次回投与前の不安による

3 患者さんに伝える観察ポイント



食事・水分がとれない状態が1日以上続いているか



下痢が1日4回以上、または血便・発熱を伴っていないか



口内炎で会話や食事が困難なほど痛みが強くないか



体重減少・脱水兆候(尿量減少・めまい)がないか

4 薬剤師のチェックポイント

- ☐ 制吐薬がレジメンの催吐リスクに見合った内容・タイミングで処方されているか確認する
- ☐ 下痢へのロペラミド等の指導は、感染性腸炎の除外や用法用量を踏まえて行う
- ☐ 口内炎予防のための含嗽の実施状況を確認し、必要時は口腔ケアを指導する
- ☐ 症状が強い場合は、次コースの減量・休薬要否について処方医への確認(疑義照会)を検討する

経口摂取不良・高度の下痢・発熱を伴う症状は、外来対応の限界を超えている可能性がある。様子見にせず、早めの受診勧奨を。